

Dược liệu, công cụ thiên nhiên và luyện tập cho giấc ngủ sâu

Bản nháp v0.1, ngày 05/10/2026. Chuyên đề thuộc trụ **Ngủ nghỉ**, nối tiếp *Nghiên cứu chuyên sâu về giấc ngủ và Giúp ngủ sâu: từ nguyên lý tới công cụ*. Ký hiệu: ☞ = Lục Dưỡng vận dụng; **[C1] [C2] [C3]** = cấp bằng chứng (lý luận v0.3, mục IX).

Trạng thái kiểm chứng: nguồn đánh dấu (**đã kiểm**) đã được đối chiếu sơ bộ qua tra cứu trực tuyến ngày 05/10/2026 (ở mức tóm tắt và trang công bố, chưa đọc toàn văn). Phần còn lại cần kiểm tra lại.

Cảnh báo: phần dược liệu **chỉ để tham khảo nội bộ và làm việc với hội đồng**. Lục Dưỡng phiên bản đầu **không gợi ý, không bán dược liệu** (lý luận mục X). Mọi sản phẩm dược liệu trong tương lai cần **lượng y, dược sĩ, bác sĩ thẩm định**, kiểm nghiệm chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Tóm tắt một trang

Phần A. Dược liệu và công cụ thiên nhiên

- Không có dược liệu nào "làm ngủ sâu" một cách chắc chắn. Bằng chứng tốt nhất chỉ ở mức **cải thiện chất lượng giấc ngủ tự đánh giá, hiệu quả nhỏ đến vừa [C2]**.
- Nhóm có bằng chứng tốt nhất: **toan táo nhân (bài Toan táo nhân thang), hoa cúc La Mã, nữ lang (valerian), tinh dầu oải hương uống dạng chuẩn hoá (cho lo âu kèm mất ngủ), ashwagandha**.
- Dược liệu Việt thường dùng (**tâm sen, lạc tiên, lá vông nem, lá dâu...**) có kinh nghiệm dân gian lâu đời nhưng **bằng chứng trên người rất ít [C3]**. Đây vừa là rủi ro, vừa là **cơ hội nghiên cứu** cho Cội Wellness.
- Công cụ thiên nhiên không uống** (ngâm chân, xoa bóp, tinh dầu xông nhẹ, ánh sáng, thiên nhiên) **an toàn hơn và nên ưu tiên trước**.

Phần B. Luyện tập

- Luyện tập là **đòn bẩy mạnh và an toàn hơn dược liệu**.
- Thái cực quyền** cho mất ngủ mạn tính ở người từ 50 tuổi: **kém CBT-I lúc kết thúc 3 tháng, nhưng tương đương CBT-I sau 15 tháng** (thử nghiệm *BMJ* 2025) (**đã kiểm**).
- Bát đoạn cẩm, yoga, vận động thể lực thông thường** đều cải thiện chất lượng giấc ngủ ở mức nhỏ đến vừa (**đã kiểm**).
- "**Luyện ngủ**" theo nguyên lý CBT-I (giờ dậy cố định, kiểm soát kích thích, cô đặc giấc ngủ) là phương pháp có bằng chứng mạnh nhất cho mất ngủ mạn tính [C1].

PHẦN A. DƯỢC LIỆU VÀ CÔNG CỤ THIÊN NHIÊN

A1. Nguyên tắc đánh giá dược liệu cho giấc ngủ

Trước khi xem từng vị, cần hiểu sáu vấn đề chung:

- Hiệu quả thường nhỏ.** Các phân tích gộp cho thấy cải thiện chất lượng giấc ngủ tự đánh giá; tác động lên giấc ngủ đo khách quan (đa ký giấc ngủ, actigraphy) thường yếu hoặc không có.
- Hiệu ứng giả dược lớn** trong nghiên cứu về giấc ngủ; nghiên cứu không có nhóm chứng rất dễ cho kết quả "đẹp".
- Chất lượng sản phẩm không đồng đều:** khác loài, khác bộ phận, khác cách chiết, khác hàm lượng hoạt chất. Một nghiên cứu tốt về sản phẩm A **không áp dụng** cho sản phẩm B cùng tên.
- Nguy cơ trộn tân dược:** sản phẩm "thảo dược an thần" trôi nổi có nguy cơ bị trộn thuốc an thần tân dược [cần số liệu kiểm nghiệm tại Việt Nam].
- Tương tác thuốc:** dược liệu an thần cộng hưởng với rượu, thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống động kinh, thuốc chống đông...
- Đối tượng đặc biệt:** thai kỳ, cho con bú, trẻ em, người cao tuổi, bệnh gan thận, chuẩn bị phẫu thuật, người lái xe, vận hành máy.

Theo Đông y: dược liệu an thần phải **biện chứng** (thực hay hư, hàn hay nhiệt, tạng nào). Cùng là mất ngủ, Tâm Tỳ lưỡng hư dùng khác Can hỏa vượng. Dùng đại trà không biện chứng là trái nguyên tắc cổ truyền 📖.

A2. Phân loại dược liệu an thần trong Đông y

Nhóm	Cơ chế cổ truyền	Đại diện	Dùng cho
Dưỡng tâm an thần	Bổ dưỡng tâm huyết, an thần	Toan táo nhân, bá tử nhân, viễn chí, long nhãn nhục, lạc tiên (theo kinh nghiệm Việt), lá vông	Thể hư : hay mơ, dễ tỉnh, hồi hộp, mệt
Trọng trấn an thần	Khoáng vật, vỏ sò nặng, trấn kinh	Long cốt, mẫu lệ, chu sa	Thể thực : hoảng hốt, giật mình. Chu sa chứa thủy ngân, không dùng
Thanh tâm hỏa	Thanh nhiệt ở tâm	Tâm sen (liên tâm), chi tử, hoàng liên	Bứt rứt, nóng trong, khó ngủ
Bình can, sơ can	Giảm can hỏa, giải uất	Câu đằng, thiên ma, hợp hoan bì, hoa nhài	Căng thẳng, dễ cáu, đau đầu

A3. Dược liệu có bằng chứng lâm sàng tốt nhất

1. Toan táo nhân và bài Toan táo nhân thang

- **Nguồn gốc:** hạt táo chua (*Ziziphus jujuba* var. *spinosa*). Bài Toan táo nhân thang có từ *Kim quỹ yếu lược* (Trương Trọng Cảnh), chủ trị "hư lao, hư phiền bất đắc miên".
- **Bằng chứng:** tổng quan hệ thống và phân tích gộp (9 thử nghiệm, 905 bệnh nhân) cho thấy Toan táo nhân thang **cải thiện chất lượng giấc ngủ tự đánh giá so với giả dược, lợi ích ngắn hạn (đã kiểm)**. Ở Đài Loan, toan táo nhân là dược liệu được kê nhiều thứ hai cho mất ngủ (**đã kiểm**).
- **Cơ chế đề xuất:** hoạt chất saponin (jujuboside) và flavonoid (spinosin) tác động hệ GABA và serotonin (chủ yếu nghiên cứu tiền lâm sàng).
- **Cấp:** C2 (nhiều nghiên cứu nhưng chất lượng vừa, phần lớn ở Trung Quốc).
- **Lưu ý:** cần biện chứng (thể hư); chất lượng hạt và cách bào chế ảnh hưởng hiệu quả.

2. Hoa cúc La Mã (chamomile, *Matricaria chamomilla*)

- **Bằng chứng:** phân tích gộp Hieu và cộng sự (*Phytotherapy Research* 2019, 12 thử nghiệm): **cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ** (SMD $-0,73$), an toàn; nhưng thử nghiệm duy nhất trên **mất ngủ thì không thấy cải thiện mức độ mất ngủ (đã kiểm)**.
- **Cấp:** C2.
- **Ý nghĩa:** phù hợp như **trà thư giãn buổi tối** cho người ngủ kém nhẹ; không phải "thuốc chữa mất ngủ".
- **Lưu ý:** dị ứng ở người dị ứng họ Cúc; có thể tương tác thuốc chống đông (thận trọng).

3. Nữ lang (valerian, *Valeriana officinalis*)

- **Bằng chứng:** phân tích gộp Shinjyo và cộng sự (*J Evid Based Integr Med* 2020, 60 nghiên cứu, 6.894 người): **có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ tự đánh giá và giảm lo âu**, không có biến cố nặng; kết quả **đáng tin hơn khi dùng chế phẩm toàn rễ có chất lượng đồng đều (đã kiểm)**. Một số tổng quan khác cho kết quả không nhất quán (**đã kiểm sự tồn tại**).
- **Cấp:** C2.
- **Lưu ý:** mùi khó chịu; hiếm gặp ảnh hưởng gan; không dùng cùng rượu, thuốc an thần; thai kỳ chưa đủ dữ liệu.

4. Tinh dầu oải hương dạng uống chuẩn hoá (Silexan)

- **Bằng chứng:** các phân tích gộp cho thấy Silexan **giảm lo âu** so với giả dược và **cải thiện giấc ngủ ở người rối loạn lo âu**, an toàn tốt, không thấy hội chứng cai (**đã kiểm**).
- **Cấp:** C1-C2 (cho lo âu kèm rối loạn giấc ngủ, với **đúng chế phẩm chuẩn hoá này**).
- **Lưu ý quan trọng:** kết quả **chỉ áp dụng cho chế phẩm chuẩn hoá đã nghiên cứu**, không áp dụng cho tinh dầu oải hương thông thường. **Tuyệt đối không uống tinh dầu thông thường**. Tác dụng phụ hay gặp: ợ hơi mùi oải hương.

5. Ashwagandha (*Withania somnifera*)

- **Bằng chứng:** phân tích gộp Cheah và cộng sự (*PLoS One* 2021, 5 thử nghiệm, 400 người): **cải thiện giấc ngủ ở mức nhỏ nhưng có ý nghĩa** (SMD $-0,59$); chưa đủ dữ liệu an toàn dài hạn (**đã kiểm**).
- **Cấp:** C2.
- **Lưu ý:** có báo cáo tổn thương gan; ảnh hưởng tuyến giáp; tránh trong thai kỳ, bệnh tự miễn, đang dùng thuốc tuyến giáp hoặc an thần. Không phải dược liệu truyền thống Việt Nam.

6. Magnesium (khoáng chất, không phải dược liệu)

- **Bằng chứng:** phân tích gộp Mah và Pitre (*BMC Complement Med Ther* 2021, 3 thử nghiệm, 151 người cao tuổi): thời gian vào giấc **giảm khoảng 17 phút** so với giả dược, nhưng **chất lượng bằng chứng thấp**, chưa đủ để bác sĩ khuyến nghị chắc chắn (**đã kiểm**).
- **Cấp:** C2 (yếu).
- **Lưu ý:** thận trọng ở người bệnh thận; gây tiêu chảy ở liều cao; tương tác với một số kháng sinh, thuốc loãng xương.

A4. Dược liệu Việt Nam thường dùng cho giấc ngủ

Dược liệu	Bộ phận	Kinh nghiệm cổ truyền	Bằng chứng hiện đại	Cấp	Lưu ý an toàn
Tâm sen (liên tâm)	Mầm xanh trong hạt sen (<i>Nelumbo nucifera</i>)	Thanh tâm hỏa, an thần; trị khó ngủ do nóng bứt rứt	Các bộ phận khác của cây sen (lá, thân rễ) tăng giấc ngủ NREM ở động vật qua thụ thể GABA-A (đã kiểm); một nghiên cứu rất nhỏ trên người dùng hỗn hợp sen và <i>Rhodiola</i> (13 người hoàn thành) (đã kiểm). Chưa thấy thử nghiệm có đối chứng trên người cho riêng tâm sen	C3	Tính hàn, đắng: thận trọng với người tỳ vị hư hàn (hay lạnh bụng, đi ngoài lỏng); có thể làm hạ huyết áp, chậm nhịp tim (alkaloid liensinine, neferine); người huyết áp thấp, đang dùng thuốc tim mạch cần hỏi bác sĩ
Lạc tiên	Toàn cây (<i>Passiflora foetida</i> ở Việt Nam)	Dưỡng tâm an thần; trị mất ngủ, hồi hộp	Nghiên cứu châu Âu chủ yếu trên loài khác (<i>Passiflora incarnata</i>), bằng chứng nhỏ cho lo âu, giấc ngủ. Không suy diễn sang loài Việt Nam	C3	Cần xác định đúng loài; thận trọng khi dùng cùng thuốc an thần; thai kỳ chưa đủ dữ liệu
Lá vông nem	Lá (<i>Erythrina variegata</i>)	An thần, trị mất ngủ	Không tìm thấy nghiên cứu trên người trong lần tra cứu này. Chi <i>Erythrina</i> chứa alkaloid có tác dụng lên thần kinh	C3	Cần lương y và dược sĩ đánh giá độc tính, liều dùng ; tránh tự dùng liều cao, kéo dài

Dược liệu	Bộ phận	Kinh nghiệm cổ truyền	Bằng chứng hiện đại	Cấp	Lưu ý an toàn
Lá dâu tằm	Lá (<i>Morus alba</i>)	Thanh can, sáng mắt; dân gian dùng làm trà để ngủ	Chủ yếu nghiên cứu về đường huyết; bằng chứng giấc ngủ rất ít	C3	Có thể hạ đường huyết; thận trọng với người dùng thuốc tiểu đường
Long nhãn nhục	Cùi nhãn sấy	Bổ tâm tỳ, dưỡng huyết an thần; dùng trong bài Quy tỳ thang	Bằng chứng trên người rất ít	C3	Ngọt, tính ấm: thận trọng với người tiểu đường, thể nhiệt
Hoa nhài, hoa sen	Hoa (ướp trà)	Thư giãn, thơm	Mùi hương có thể giúp thư giãn (bằng chứng nhỏ)	C3	Trà ướp hoa vẫn có caffeine nếu là trà xanh, trà đen
Bình vôi	Củ (<i>Stephania</i>)	An thần, giảm đau	Chứa rotundin (L-tetrahydropalmatine) có tác dụng an thần	—	Không dùng như thực phẩm: rotundin là hoạt chất thuốc , đã có báo cáo ngộ độc, tổn thương gan với L-tetrahydropalmatine ở nước ngoài [cần kiểm tra]; chỉ dùng theo chỉ định

Kết luận cho dược liệu Việt: đây là khoảng trống bằng chứng lớn. Cội Wellness có thể **hợp tác viện nghiên cứu, trường y dược** để làm thử nghiệm có đối chứng (lý luận mục IX, bậc 4), ví dụ trà tâm sen hoặc lạc tiên chuẩn hoá. Đây là cách hiện thực hoá **"Nam dược trị Nam nhân"** theo chuẩn hiện đại.

A5. Những dược liệu và sản phẩm cần tránh

Sản phẩm	Lý do	Nguồn
Kava (<i>Piper methysticum</i>)	Gây tổn thương gan , có báo cáo suy gan; bị cấm hoặc hạn chế ở nhiều nước	LiverTox, FDA (đã kiểm)
Chu sa	Chứa thủy ngân	Độc tính kim loại nặng [C1]
Thuốc "đông y" an thần không rõ nguồn gốc	Nguy cơ trộn tân dược an thần, kim loại nặng	Cần số liệu kiểm nghiệm Việt Nam
Rượu ngâm, rượu thuốc "để ngủ"	Rượu làm vỡ giấc nửa sau đêm	Ebrahim 2013 (đã kiểm, trong tài liệu ngủ sâu)
Uống tinh dầu thông thường	Độc tính, kích ứng	[C1]

Sản phẩm	Lý do	Nguồn
Melatonin tự mua	Cần chỉ định; không phải lựa chọn hàng đầu cho mất ngủ mạn tính	Xem tài liệu ngữ sâu

A6. Công cụ thiên nhiên không uống (nên ưu tiên)

Công cụ	Cách làm	Bằng chứng	Cấp	An toàn
Ngâm chân nước ấm (có thể thêm gừng, ngải cứu, lá bưởi cho thơm)	Nước 40–42 °C, 10–20 phút, 1–2 giờ trước ngủ	Phân tích gộp Haghayegh 2019 về làm ấm trước ngủ (đã kiểm); tác dụng chính đến từ nhiệt, không phải thảo dược	C2	Người tiểu đường mất cảm giác chân: thử nhiệt độ cẩn thận; không ngâm khi có vết thương
Xông hương nhẹ (oải hương, hoa nhài, sả chanh) bằng máy khuếch tán	Vài giọt, 15–30 phút trước ngủ, tắt khi ngủ	Hít tinh dầu oải hương có bằng chứng nhỏ cho thư giãn, giấc ngủ	C2	Thông thoáng phòng; thận trọng với người hen, trẻ nhỏ, thú cưng; không đốt nến, nhang trong phòng kín
Gối thảo mộc (vỏ đậu xanh, hoa cúc khô, lá trà)	Gối mát, thơm nhẹ	Kinh nghiệm dân gian	C3	Phơi thường xuyên tránh mốc (nhất là mùa nồm)
Xoa bóp bàn chân, huyết Dũng tuyến, Thần môn, An miên	5–10 phút trước ngủ	Xoa bóp nói chung giúp thư giãn [C2]; bấm huyết cho mất ngủ có nghiên cứu nhưng chất lượng không đều	C2 (thư giãn) / C2–C3 (huyết)	Nhẹ nhàng; tránh vùng da tổn thương
Ánh sáng tự nhiên buổi sáng	10–30 phút ngoài trời	Chỉnh đồng hồ sinh học	C1	Che nắng khi UV cao
Thời gian trong thiên nhiên	Đi bộ công viên, vườn	Giảm căng thẳng	C2	—
Âm thanh thiên nhiên (mưa, suối)	Phát nhẹ để che tiếng ồn	Chủ yếu giúp che tiếng ồn	C2	Âm lượng thấp

PHẦN B. LUYỆN TẬP CHO GIẤC NGỦ SÂU VÀ CHẤT LƯỢNG

B1. Vì sao luyện tập giúp ngủ

Cơ chế	Giải thích	Cấp
Tăng áp lực ngủ	Tiêu hao năng lượng, tích lũy nhu cầu phục hồi	C1–C2

Cơ chế	Giải thích	Cấp
Hạ thân nhiệt sau tập	Thân nhiệt tăng khi tập, hạ sau đó vài giờ, hỗ trợ vào giấc	C2
Củng cố nhịp sinh học	Vận động ban ngày, ngoài trời là tín hiệu "ngày"	C2
Giảm lo âu, trầm cảm	Hai nguyên nhân hàng đầu của mất ngủ	C1
Giảm kích thích (với bài thân - tâm)	Thái cực, khí công, yoga kết hợp thở và chú tâm	C2
Giảm cân, giảm ngưng thở khi ngủ	Ở người thừa cân	C1- C2

Đông lý: "dương khí tận" thì ngủ: ban ngày dương động đủ thì đêm âm tĩnh trọn ☯. Hoa Đà: động thì "huyết mạch lưu thông, bệnh bất đắc sinh".

B2. Bằng chứng theo loại hình luyện tập

Loại hình	Bằng chứng chính	Cấp
Vận động thể lực nói chung	Kredlow 2015 (66 nghiên cứu): vận động cấp tính có lợi ích nhỏ cho thời gian ngủ, hiệu quả giấc ngủ, ngủ sâu; vận động đều đặn có lợi ích vừa cho chất lượng giấc ngủ (đã kiểm)	C1- C2
Thái cực quyền	Siu và cộng sự (<i>JAMA Network Open</i> 2021), người từ 60 tuổi mất ngủ: Thái cực và vận động thông thường đều cải thiện giấc ngủ so với nhóm chứng; Thái cực cải thiện giấc ngủ tự đánh giá rõ hơn lúc kết thúc, tương đương sau 24 tháng (đã kiểm)	C1- C2
Thái cực quyền so với CBT-I	Thử nghiệm không kém hơn (<i>BMJ</i> 2025), 200 người từ 50 tuổi mất ngủ mạn tính, 24 buổi nhóm x 1 giờ trong 3 tháng: tháng 3, CBT-I giảm ISI 11,19 điểm, Thái cực giảm 6,67 (Thái cực kém hơn); tháng 15, CBT-I giảm 10,18, Thái cực giảm 9,51 (không kém hơn); không có biến cố bất lợi (đã kiểm)	C1
Bát đoạn cẩm, khí công	Phân tích gộp: Bát đoạn cẩm cải thiện chất lượng giấc ngủ (SMD -0,55, 19 thử nghiệm); hiệu quả rõ hơn ở người có bệnh; cũng hiệu quả ở người cao tuổi (đã kiểm)	C2
Yoga	Phân tích gộp ở phụ nữ có vấn đề giấc ngủ (19 thử nghiệm, 1.832 người): cải thiện vấn đề giấc ngủ (SMD -0,33) và chất lượng giấc ngủ (SMD -0,54) (đã kiểm)	C2
Tập kháng lực (sức cơ)	Cải thiện chất lượng giấc ngủ trong một số nghiên cứu	C2
Tập buổi tối	Tổng quan về tập buổi tối ở người khỏe (<i>Sports Medicine</i>): nhìn chung không hại giấc ngủ, trừ tập cường độ cao sát giờ ngủ (dưới khoảng 1 giờ) (đã kiểm sự tồn tại)	C2

Kết luận:

- **Có tập là tốt.** Loại hình nào người dùng **duy trì được** quan trọng hơn loại hình "tốt nhất".
- **Thái cực, Bát đoạn cẩm** đặc biệt hợp với người trung niên, cao tuổi, người căng thẳng, và hợp văn hoá Á Đông.

- Hiệu quả lên giấc ngủ cần **vài tuần đến vài tháng** luyện tập đều; Thái cực cho thấy lợi ích **bền** sau 1 năm.

B3. Liều lượng và thời điểm

Yếu tố	Khuyến nghị 📌	Cơ sở
Tần suất	3-5 buổi/tuần	Phần lớn thử nghiệm dùng 2-5 buổi/tuần
Thời lượng	30-60 phút/buổi (có thể chia nhỏ)	Thử nghiệm Thái cực: 1 giờ × 2 buổi/tuần
Cường độ	Vừa (nói được câu, không hát được)	Khuyến nghị WHO; cường độ vừa an toàn và hiệu quả
Thời điểm tốt nhất	Sáng hoặc chiều; ngoài trời nếu có thể (thêm ánh sáng)	Ánh sáng và nhịp sinh học
Buổi tối	Bài nhẹ (Bát đoạn chậm, yoga phục hồi, giãn cơ) vẫn tốt; tránh cường độ cao trong khoảng 1 giờ trước ngủ	Tổng quan về tập buổi tối
Thời gian thấy hiệu quả	4-12 tuần	Các thử nghiệm kéo dài 8-12 tuần

B4. Bộ bài tập cho giấc ngủ 📌

1. Buổi sáng: "Đánh thức dương khí" (15-30 phút)

- Đi bộ nhanh ngoài trời hoặc **Bát đoạn chậm** đầy đủ tám thức.
- Mục tiêu: ánh sáng, nhịp sinh học, áp lực ngủ cho đêm.

2. Buổi chiều: "Vận động chính" (30-45 phút, 3-5 buổi/tuần)

- Một trong các lựa chọn: đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, cầu lông, **Thái cực quyền**, tập sức cơ (2 buổi/tuần).
- Mục tiêu: áp lực ngủ, giảm lo âu, hạ thân nhiệt vào buổi tối.

3. Buổi tối: "Thu liễm" (10-20 phút, 1-2 giờ trước ngủ)

Chuỗi gợi ý, cần chuyên gia biên soạn và quay video:

1. **Giãn cơ chậm** cổ, vai, lưng, hông (5 phút).
2. **Bát đoạn chậm** hoặc 3-4 thức chọn lọc, nhấn mạnh thở ra dài (5-10 phút).
3. **Ngâm chân** (10-15 phút), kết hợp **xoa bóp bàn chân**.

4. Trên giường: "Ngủ lòng trước, ngủ mắt sau" (5-15 phút)

- **Thở bốn - sáu** (hít 4 nhịp, thở ra 6 nhịp) hoặc **thở bụng**.
- **Quét thân** hoặc **thư giãn cơ tăng tiến** (căng rồi thả từng nhóm cơ).

- **Yoga Nidra** (nằm thư giãn có hướng dẫn) là lựa chọn khác; có tổng quan hệ thống gần đây về hiệu quả cho rối loạn giấc ngủ (**đã kiểm sự tồn tại**) [C2].

5. Khi thức giấc giữa đêm

- Không xem điện thoại, không nhìn đồng hồ.
- Thở chậm 5 phút. Nếu sau khoảng 20 phút vẫn tỉnh, ra khỏi giường, làm việc nhẹ dưới đèn mờ, buồn ngủ mới quay lại.

B5. "Luyện ngủ": huấn luyện theo nguyên lý CBT-I

CBT-I là "luyện tập cho chính giấc ngủ", có bằng chứng mạnh nhất cho mất ngủ mạn tính [C1].

Thành phần	Cách làm	App làm được?
Giờ dậy cố định	Dậy cùng giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần	Có
Kiểm soát kích thích	Chỉ lên giường khi buồn ngủ; nằm khoảng 20 phút không ngủ thì ra khỏi giường; giường chỉ để ngủ	Có
Vệ sinh giấc ngủ	Cà phê, rượu, bữa tối, ánh sáng, phòng ngủ	Có
Thư giãn	Thở, quét thân, thư giãn cơ	Có
Nhận thức	Thay suy nghĩ "phải ngủ đủ 8 tiếng", "mất ngủ sẽ hỏng hết ngày mai"	Có, ở mức giáo dục
Hạn chế, cô đặc giấc ngủ	Giới hạn thời gian nằm giường bằng thời gian ngủ thực, rồi tăng dần	Chỉ dưới hướng dẫn chuyên môn (chống chỉ định ở người động kinh, rối loạn lưỡng cực, lái xe nghề, ngưng thở khi ngủ chưa điều trị...)

→ Cội Wellness nên **hợp tác chương trình CBT-I** số có **chuyên gia giám sát** cho người mất ngủ mạn tính, thay vì tự làm toàn bộ.

B6. Chương trình luyện tập 8 tuần cho giấc ngủ sâu 📝

Tuần	Luyện tập ban ngày	Luyện tập buổi tối	Luyện ngủ
1	Đi bộ 20 phút × 3 buổi	Thở bốn – sáu 5 phút trên giường	Chọn giờ dậy cố định
2	Đi bộ 30 phút × 4 buổi; ra nắng sáng	Thêm ngâm chân	Cà phê trước 14h; không rượu tối
3	Học Bát đoạn cẩm (4 thức đầu)	Giãn cơ chậm 5 phút	Quy tắc 20 phút
4	Bát đoạn cẩm đủ 8 thức, 4 buổi	Quét thân trên giường	Giường chỉ để ngủ
5	Thêm 2 buổi tập sức cơ 15 phút	Bát đoạn cẩm chậm buổi tối	"Gác lại ngày hôm nay"

Tuần	Luyện tập ban ngày	Luyện tập buổi tối	Luyện ngủ
6	Thái cực quyền (lớp hoặc video) 2 buổi	Xoa bóp bàn chân	Xử lý suy nghĩ lo âu về giấc ngủ
7	Tổng 150 phút vận động vừa/tuần	Chọn chuỗi buổi tối yêu thích	Duy trì
8	Duy trì; đánh giá lại	Duy trì	Đánh giá ISI, chỉ số "đã được nghỉ"

Đánh giá: chỉ số "sáng nay đã được nghỉ" mỗi ngày; ISI (mức độ mất ngủ) ở tuần 0, 4, 8. Không cải thiện sau 8 tuần, hoặc ISI ở mức trung bình - nặng → **khuyến đi khám**, giới thiệu CBT-I.

B7. An toàn khi luyện tập

- Sàng lọc trước vận động (PAR-Q+) theo tài liệu trụ Luyện tập.
- Người cao tuổi, có nguy cơ ngã: bài có vịn ghế; Thái cực với người hướng dẫn.
- Bệnh tim mạch, huyết áp chưa kiểm soát: hỏi bác sĩ trước khi tập cường độ vừa trở lên.
- Thai kỳ: chọn bài phù hợp, hỏi bác sĩ sản.
- Đau tăng, chóng mặt, đau ngực khi tập: dừng ngay (cờ đỏ trụ Luyện tập).

PHẦN C. ĐỀ XUẤT CHO CỘI WELLNESS

C1. Thứ tự ưu tiên

Ưu tiên	Nội dung	Lý do
1	Chương trình luyện tập 8 tuần + bộ bài buổi tối + luyện ngủ cơ bản	Bằng chứng tốt, an toàn, đúng định vị dưỡng sinh
2	Video Bát đoạn cẩm, Thái cực cơ bản do chuyên gia trình diễn	Bằng chứng tốt cho giấc ngủ; hợp văn hoá
3	Công cụ không uống: bộ ngâm chân, gối thảo mộc, tinh dầu xông nhẹ, xoa bóp	An toàn, dễ thương mại hoá
4	Hợp tác CBT-I số, kết nối khám giấc ngủ	Cho người mất ngủ mạn tính
5	Trà thảo mộc thư giãn (hoa cúc, hoa nhài không caffeine)	Bằng chứng nhỏ, an toàn tương đối; nói đúng mức "thư giãn", không "chữa mất ngủ"
6 (dài hạn)	Nghiên cứu có đối chứng cho dược liệu Việt (tâm sen, lạc tiên) cùng viện, trường	Khoảng trống bằng chứng; cơ hội khác biệt

Ưu tiên	Nội dung	Lý do
Không làm	Bán dược liệu an thần, thực phẩm chức năng "trị mất ngủ", kava, bình vôi, melatonin	An toàn, pháp lý

C2. Cách nói đúng mức (mẫu)

- "Hoa cúc là trà thư giãn buổi tối. Nghiên cứu cho thấy có thể giúp chất lượng giấc ngủ, nhưng không phải thuốc chữa mất ngủ."
- "Tâm sen được người xưa dùng để thanh tâm, an thần. Khoa học mới nghiên cứu chủ yếu trên động vật. Người hay lạnh bụng, huyết áp thấp nên hỏi thầy thuốc trước khi dùng."
- "Một nghiên cứu lớn năm 2025 cho thấy tập Thái cực quyền hai buổi mỗi tuần trong ba tháng giúp người mất ngủ mạn tính cải thiện, và sau một năm hiệu quả tương đương liệu pháp tâm lý chuẩn."

C3. Khoá an toàn khi (trong tương lai) có dược liệu

- Thai kỳ, cho con bú, dưới 18 tuổi: **khoá**.
- Đang dùng thuốc ngủ, chống trầm cảm, chống động kinh, chống đông, thuốc tim mạch, tiểu đường: **khoá**, khuyên hỏi bác sĩ.
- Bệnh gan, thận: **khoá**.
- Lái xe, vận hành máy: cảnh báo buồn ngủ.
- Không dùng cùng rượu.
- Dùng không quá 2-4 tuần nếu không có thầy thuốc theo dõi.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y, dược sĩ:

- Bảng dược liệu an thần Việt Nam: loài chính xác, bộ phận, liều, chống chỉ định, cách biện chứng.
- Độc tính lá vông nem, tâm sen, bình vôi; nguồn dược liệu đạt chuẩn.
- Bài thuốc cổ truyền (Toan táo nhân thang, Quy tỳ thang, Thiên vương bổ tâm đan...): vai trò, giới hạn khi đưa vào sản phẩm đại trà.

Bác sĩ, chuyên gia giấc ngủ, phục hồi chức năng:

- Chương trình luyện tập 8 tuần; nội dung luyện ngủ an toàn trong app.
- Biên soạn, trình diễn bộ bài Bát đoạn cầm, Thái cực, giãn cơ buổi tối.
- Xếp cấp C1/C2/C3.

Pháp lý:

1. Quy định về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quảng cáo công dụng; điều kiện kinh doanh dược liệu.

Nguồn

Đã đối chiếu sơ bộ qua tra cứu trực tuyến (05/10/2026)

Dược liệu

- Toan táo nhân thang: [MSKCC – Suan Zao Ren Tang](#), [Suanzaoren formulae for insomnia \(Frontiers in Pharmacology 2018\)](#), [ASCO Post 2023](#)
- Hoa cúc, Hieu và cộng sự 2019: [ResearchGate](#)
- Nữ lang, Shinjyo và cộng sự 2020: [WestminsterResearch](#); tổng quan khác: [Umbrella review 2024](#)
- Ashwagandha, Cheah và cộng sự 2021: [PLOS One](#)
- Silexan (oải hương uống chuẩn hoá): [Meta-analysis subthreshold anxiety](#), [Network meta-analysis](#), [Scientific Reports](#)
- Magnesium, Mah và Pitre 2021: [BMC Complementary Medicine and Therapies](#)
- Sen (*Nelumbo nucifera*) và giấc ngủ: [nghiên cứu trên chuột](#), [hỗn hợp Rhodiola và sen trên người](#)
- Kava và độc tính gan: [LiverTox](#), [FDA](#)

Luyện tập

- Kredlow và cộng sự 2015: [ResearchGate](#)
- Siu và cộng sự 2021, Thái cực cho người cao tuổi mất ngủ: [JAMA Network Open](#)
- Thái cực so với CBT-I, *BMJ* 2025: [BMJ Group](#), [HKUMed](#)
- Bát đoạn cầm, khí công và giấc ngủ: [Health qigong meta-analysis](#), [Qigong ở người cao tuổi](#)
- Yoga và giấc ngủ ở phụ nữ: [BMC Psychiatry 2020](#)
- Yoga Nidra: [Sleep and Breathing](#)
- Tập buổi tối: [Sports Medicine](#)

Chưa đối chiếu, cần kiểm tra

- *Passiflora incarnata* và giấc ngủ; khác biệt với *Passiflora foetida*.
- Độc tính *Erythrina variegata*; L-tetrahydropalmatine (rotundin) và tổn thương gan.
- Nguy cơ trộn tân dược trong sản phẩm thảo dược an thần tại Việt Nam.
- Bấm huyết cho mất ngủ (các phân tích gộp).
- Tập kháng lực và giấc ngủ.